Клинические рекомендации

Грипп у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J09** — Грипп, вызванный определенным идентифицированным вирусом гриппа **J10** — Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа **J11** — Грипп, вирус не идентифицирован
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/749_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Физикальное обследование 5

3.4 Лабораторные исследования 6

3.5 Инструментальные исследования 6

3.6 Консультации специалистов 7

4. Лечение 7

4.1 Противовирусная терапия 7

4.2 Лёгкое и среднетяжёлое неосложнённое течение (амбулаторно) 7

4.3 Осложнённое, тяжёлое и крайне тяжёлое течение (стационар) 9

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9

5.1 Профилактика 9

5.2 Показания к госпитализации 10

6. Источник и актуальность 10

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Грипп — острая инфекционная болезнь с аэрогенным механизмом передачи, вызываемая вирусами гриппа A, B или C; характеризуется массовым распространением, кратковременной лихорадкой, интоксикацией и поражением респираторного тракта.
- Возбудитель подтверждается экспресс-тестом (иммунохроматография мазка из носоглотки) при обращении **не позднее 2 суток** от появления симптомов или ПЦР мазка из носоглотки; в стационаре ПЦР выполняется всем **в первые сутки** госпитализации. В период эпидемического подъёма диагноз может быть установлен и по клинико-эпидемиологическим данным.
- Противовирусные препараты прямого действия начинают **не позднее 48 часов** (занамивир — **в первые 36 часов**) от манифестации, не дожидаясь лабораторного подтверждения; наилучший эффект — при начале **в первые 12 часов**.
- **Оториноларингологу**
  1. осложнения со стороны ЛОР-органов: синуситы, отиты, тубоотиты, лакунарная и фолликулярная ангина;
  2. при подозрении на бактериальный синусит выполняется рентгенография околоносовых пазух;
  3. при выраженном затруднении носового дыхания — местные адреномиметики **не более 5 дней**.
- **Показания к госпитализации**
  1. тяжёлое и среднетяжёлое течение;
  2. проживание в общежитии, неблагоприятные условия жилой среды;
  3. принадлежность к группе риска неблагоприятного течения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Грипп (Grippus, Influenza) — острая инфекционная болезнь с аэрогенным механизмом передачи возбудителя, вызываемая вирусами гриппа A, B или C, характеризующаяся массовым распространением, кратковременной лихорадкой, интоксикацией и поражением респираторного тракта.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возбудителями являются РНК-содержащие вирусы семейства ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), роды A, B, C и D. Основные поверхностные белки — гемагглютинин (H), основной иммуноген, и нейраминидаза (N); мутации нейраминидазы приводят к резистентности к её ингибиторам. Выделяют 18 подтипов гемагглютинина и 11 вариантов нейраминидазы вируса A.

Эпидемиология

1. источник — больной в остром периоде (первые 5–7 дней), в том числе с лёгкой и бессимптомной формой, реже реконвалесцент, выделяющий вирус в среднем 2 недели;
2. механизм передачи аэрогенный (воздушно-капельный и воздушно-пылевой пути), радиус рассеивания 2–3 м; контактно-бытовой имеет значительно меньшее значение;
3. восприимчивость всеобщая; эпидемии в крупных городах длятся в среднем 6–8 недель, пандемии вызываются новыми шифтовыми вариантами вируса.

2.3 Классификация

1. **по течению** — типичное (манифестное), атипичное (бессимптомное, стёртое)
2. **по тяжести** — лёгкая, средняя, тяжёлая, очень тяжёлая (гипертоксическая) степень
3. **по характеру течения** — неосложнённое и осложнённое: специфические (вирус-ассоциированные) осложнения, бактериальные осложнения, обострение или декомпенсация хронических заболеваний

2.4 Клиническая картина

Инкубационный период — **от 1 до 4 дней**, в среднем около 48 часов. Типичный грипп у взрослых начинается внезапно.

Типичные симптомы

1. озноб, лихорадка, прострация;
2. боли в мышцах и суставах, преимущественно нижних конечностей;
3. сильная головная боль, часто со светобоязнью и болезненностью при надавливании на глазные яблоки или при движении ими;
4. вначале лёгкие респираторные симптомы: першение в горле, жжение за грудиной, непродуктивный кашель, иногда насморк;
5. позже — преобладание поражения нижних дыхательных путей, кашель стойкий и продуктивный.

Острые симптомы проходят **через 2–3 дня**, лихорадка может длиться **до 5 дней**; кашель и слабость сохраняются дни и недели.

При неосложнённом гриппе характерны лейкопения с нейтропенией, относительный лимфоцитоз и моноцитоз; СОЭ у большинства нормальная. На рентгенограмме лёгких в остром периоде — усиление сосудистого рисунка.

Критерии оценки тяжести течения гриппа

Признак	Лёгкая	Средняя	Тяжёлая	Очень тяжёлая
Лихорадка	до 38,5 °C	38,6–39,5 °C	более 39,6 °C	свыше 40,0 °C
Пульс и систолическое АД	пульс менее 90 в минуту, САД 110 мм рт. ст. и выше	пульс 90–120, САД менее 110	пульс более 120, нередко аритмичен, САД менее 90, тоны сердца глухие	пульс более 120, нередко аритмичен, САД менее 90, тоны сердца глухие
Частота дыхательных движений	16–23	более 24	более 28	более 28
Менингеальный синдром, сознание, судороги	отсутствуют	отсутствуют	менингеальный синдром возможен, оглушение, сопор, возможны судороги и бред	менингеальный синдром часто, сопор, кома, возможны судороги, часто бред и делирий
Длительность заболевания	до 6 дней	6–8 дней	9 дней и более	молниеносное течение

Осложнения гриппа

1. вирусная пневмония, ОРДС, токсический геморрагический отёк лёгких, ложный круп, острая дыхательная недостаточность;
2. инфекционно-токсический шок, инфекционно-токсическая энцефалопатия, отёк головного мозга;
3. неврологические осложнения: менингит, энцефалит, синдром Гийена — Барре, невриты; синдром Рея; миокардит;
4. вторичная бактериальная или вирусно-бактериальная пневмония, септический шок;
5. осложнения со стороны ЛОР-органов: гаймориты, отиты, фронтиты, синуситы, тубоотиты, лакунарная и фолликулярная ангина;
6. декомпенсация хронических заболеваний: бронхиальной астмы, ХОБЛ, хронической сердечной недостаточности, заболеваний печени и почек.

Осложнения возникают у 10–15% больных. Постгриппозные пневмонии развиваются **в конце 1-й — начале 2-й недели** болезни. Частые осложнения гриппа — синуситы и отиты. Тяжёлым осложнением является отёк головного мозга: сильная головная боль, рвота, судороги, нарушение сознания, менингеальный синдром.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. эпидемиологического и клинического анамнеза;
2. клинического осмотра;
3. лабораторных и специальных методов обследования.

При этом определяются клиническая форма и тяжесть болезни, осложнения и показания к терапии. В период эпидемических подъёмов диагноз «грипп» может быть установлен как по лабораторному подтверждению, так и по клиническим и эпидемиологическим данным.

3.2 Жалобы и анамнез

Что уточнить

1. сроки появления лихорадки и интоксикации, ломоту в мышцах и суставах, боль при движении глазных яблок, катаральные явления, боль в грудной клетке;
2. контакт с больным гриппоподобным заболеванием или с подтверждённым гриппом **менее чем за 7 дней** до первых симптомов, эпидемический подъём заболеваемости;
3. приём противовирусных препаратов до обращения;
4. сопутствующие хронические заболевания и беременность.

3.3 Физикальное обследование

При общем осмотре

1. цвет и влажность кожи и видимых слизистых оболочек, инъекция сосудов склер;
2. одышка, мокрота, дистанционные хрипы;
3. положение и поведение пациента;
4. жизненно важные показатели: ЧДД, АД, ЧСС, температура тела.

3.4 Лабораторные исследования

Общий анализ крови и общий анализ мочи выполняются всем пациентам с подозрением на грипп.

1. **неосложнённый грипп** — нормоцитоз или лейкопения, нейтропения, эозинопения, относительный лимфо- и моноцитоз
2. **бактериальные осложнения (пневмония, синусит)** — нарастают лейкоцитоз, палочкоядерный нейтрофилёз, СОЭ
3. **интерстициальное вирусное поражение лёгких** — лейкопения, нейтрофилёз с палочкоядерным сдвигом, анемия, тромбоцитопения

Специфическая диагностика

1. амбулаторно — иммунохроматографический экспресс-тест мазка из носоглотки на антигены вирусов А и В всем, кто обратился **не позднее 2 суток** от появления симптомов;
2. амбулаторно — ПЦР мазка из носоглотки по клинико-эпидемиологическим показаниям: эпидемический очаг, лихорадка **выше 38**, подозрение на поражение нижних дыхательных путей, возраст **старше 65 лет**, хроническая соматическая патология;
3. в стационаре — ПЦР мазка из носоглотки всем пациентам с симптомами ОРВИ **в первые сутки** госпитализации.

Для дифференциальной диагностики выявляют другие возбудители ОРВИ и SARS-CoV-2: экспресс-тестом и ПЦР мазков из носо- и ротоглотки; в стационаре — всем в первый день госпитализации. При подозрении на поражение нижних дыхательных путей исследуют мокроту, аспират из трахеи, жидкость бронхоальвеолярного лаважа.

Серологическое исследование парных сывороток (первая — в день диагноза, вторая — через 2–3 недели) применяется в стационаре для ретроспективной диагностики при невозможности ПЦР; достоверно нарастание титра **в 4 раза и более**.

При тяжёлом и осложнённом течении

1. биохимический анализ крови: билирубин, альбумин, мочевина, креатинин, глюкоза, АСТ, АЛТ, тропонины;
2. кислотно-основное состояние и газы крови — при дыхательной недостаточности;
3. коагулограмма — при геморрагическом синдроме;
4. электролиты крови;
5. маркеры воспаления: фибриноген, прокальцитонин, С-реактивный белок (СРБ).

3.5 Инструментальные исследования

Пульсоксиметрия выполняется всем пациентам на всех этапах помощи; при SpO_2 **менее 90%** исследуют газы артериальной крови и лактат.

Рентгенография или КТ органов грудной клетки показана при явлениях бронхита с физикальными признаками поражения лёгочной ткани; ЭКГ — при осложнённом течении и аускультативных изменениях в сердце.

Рентгенография околоносовых пазух выполняется при катаральных проявлениях в остром периоде или их появлении на фоне терапии, при подозрении на синусит, вызванный присоединением бактериальной флоры.

Спинномозговая пункция с исследованием ликвора проводится при менингеальных симптомах для разграничения менингизма и менингита; при менингизме изменений ликвора нет.

3.6 Консультации специалистов

1. **невролог** — при явлениях менингоэнцефалита
2. **пульмонолог** — при признаках пневмонии
3. **гематолог** — при выраженных гематологических изменениях и геморрагическом синдроме
4. **кардиолог** — при миокардите, острой сердечно-сосудистой недостаточности
5. **акушер-гинеколог** — при гриппе на фоне беременности

Осмотр анестезиолога-реаниматолога для перевода в ОРИТ показан при быстропрогрессирующей острой дыхательной недостаточности: ЧДД **более 25** в минуту, SpO_2 **менее 92%**, а также при другой органной недостаточности (**2 и более балла** по шкале SOFA).

Дифференциальная диагностика проводится с двумя группами инфекций: протекающими с катарально-респираторным синдромом и с ранним развитием лихорадочно-интоксикационного синдрома.

---

4. Лечение

4.1 Противовирусная терапия

Противовирусные препараты прямого действия как препараты первой линии начинают **не позднее 48 часов** (занамивир — **в первые 36 часов**) после манифестации всем пациентам с симптомами гриппа.

1. лечение начинают немедленно, не дожидаясь лабораторного подтверждения;
2. вакцинация и тяжесть болезни на решение не влияют;
3. наилучший эффект достигается при начале **в первые 12 часов**;
4. при отсутствии лечения в ранние сроки препарат может быть начат на любом этапе разгара болезни при предполагаемой репликации вируса.

Амантадин и римантадин для лечения гриппа не рекомендуются: большинство штаммов вируса А к ним резистентны.

4.2 Лёгкое и среднетяжёлое неосложнённое течение (амбулаторно)

Ингибиторы нейраминидазы — осельтамивир и занамивир. Пациентам вне группы риска с неосложнённым гриппом их назначать не следует.

1. осельтамивир: внутрь по 75 мг 2 раза в сутки, 5 дней; с осторожностью при беременности и грудном вскармливании;
2. занамивир: по 2 ингаляции (по 5 мг) 2 раза в сутки, 5 дней; при резистентности к осельтамивиру, беременным, при тяжёлой почечной недостаточности; не распылять аэрозольным ингалятором.

Балоксавир марбоксил назначается взрослым и детям **старше 12 лет**, в том числе с риском осложнений; прекращает выделение вируса **в течение 1 суток** и активен в отношении штаммов, резистентных к ингибиторам нейраминидазы.

1. масса тела **40–80 кг**: 40 мг внутрь однократно;
2. масса тела **80 кг и более**: 80 мг однократно.

Другие противовирусные препараты прямого действия

1. умифеновир: внутрь до еды по 200 мг 4 раза в сутки, 5 дней; противопоказан в I триместре беременности;
2. риамиловир: внутрь по 250 мг 3 раза в сутки, 5 дней, начать **не позднее 2-го дня** болезни; противопоказан при беременности и грудном вскармливании;
3. энисамия йодид: внутрь по 500 мг 3 раза в сутки, 5–7 дней.

Иммунотропные препараты с опосредованным противовирусным действием (интерфероны, иммуностимуляторы) применяются как препараты второй линии.

1. имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты;
2. ХС221GI;
3. интерферон альфа-2b, интерферон гамма человеческий рекомбинантный интраназально;
4. тилорон;
5. меглюмина акридонацетат;
6. азоксимера бромид;
7. Эргоферон, Рафамин;
8. инозин пранобекс.

При отсутствии эффекта **в течение 24 часов** переходят на противовирусные препараты прямого действия.

1. имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты: 90 мг 1 раз в сутки, 5–7 дней, начать желательно **не позднее 2 суток**; при выраженных симптомах и сопутствующих заболеваниях — 180 мг/сут первые 3 дня;
2. ХС221GI: по 100 мг 2 раза в день, 5 дней;
3. интерферон альфа-2b: интраназально по 3 капли в каждый носовой ход 5–6 раз в день, 5 дней; интерферон гамма: по 2 капли 5 раз в день;
4. тилорон: 125 мг 1 раз в сутки первые 2 дня, затем 125 мг через день (курсовая доза 750 мг);
5. меглюмина акридонацетат: 450–600 мг 1 раз в сутки на 1, 2, 4, 6, 8-е сутки;
6. азоксимера бромид: по 1 таблетке сублингвально 2 раза в день, 7 дней;
7. инозин пранобекс: 6–8 таблеток в сутки в 3–4 приёма.

Всем пациентам показана пероральная дезинтоксикационная терапия: 2–3 литра жидкости в сутки.

При гипертермии **выше 38 °С**, мышечных и суставных болях применяют НПВП или анилиды.

1. ибупрофен: внутрь по 200–400 мг 3–4 раза в сутки, 3–10 дней, не более 1200 мг/сут;
2. парацетамол: по 500–1000 мг до 4 раз в сутки, не более 4000 мг/сут;
3. при выраженных лихорадочно-интоксикационном и респираторном синдромах — комбинации ибупрофен + парацетамол, парацетамол + фенилэфрин + фенирамин.

1. **бронхит с бронхообструкцией и влажным кашлем** — отхаркивающие препараты: ацетилцистеин, бромгексин, амброксол
2. **сухой непродуктивный надсадный кашель** — противокашлевые препараты: бутамират, комбинации с декстрометорфаном

Одновременное применение отхаркивающих и противокашлевых препаратов не рекомендуется: подавление кашлевого рефлекса способствует застою мокроты.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексной терапии ринита и риносинусита применяют местные адреномиметики **не более 5 дней**: они облегчают заложенность носа и восстанавливают проходимость слуховой трубы.

1. ксилометазолин: 0,1% раствор по 2–3 капли или 1 впрыскивание в каждый носовой ход 4 раза в день; противопоказан при беременности;
2. оксиметазолин: 0,025–0,05% раствор по 1–2 капли 2–3 раза в сутки; при беременности и грудном вскармливании — с осторожностью.

4.3 Осложнённое, тяжёлое и крайне тяжёлое течение (стационар)

При поступлении

1. оценить характер поражения органов дыхания и компенсацию сопутствующих болезней;
2. измерить основные физиологические константы;
3. выполнить рентгенографию лёгких и ЭКГ;
4. взять материал для специфической диагностики.

Сразу после поступления начинают осельтамивир, занамивир или балоксавир марбоксил в обычных дозах.

При тяжёлом или прогрессирующем заболевании и тяжёлой иммуносупрессии без ответа на стандартный режим целесообразен #осельтамивир по 150 мг 2 раза в сутки **не менее 10 дней**; с осторожностью при почечной недостаточности.

Меглюмина натрия сукцинат внутривенно капельно применяют при среднетяжёлом и тяжёлом течении и пневмонии для купирования интоксикации: в среднем 10 мл/кг в сутки, курс **до 11 дней**.

При гипоксемии проводится оксигенотерапия: при SpO_2 **менее 92%** — ингаляция кислорода через носовые катетеры или лицевую маску; при острой дыхательной недостаточности — интубация трахеи и ИВЛ, в крайне тяжёлых случаях ОРДС — ЭКМО.

Стрессовые (малые и средние) дозы системных глюкокортикостероидов применяют при рефрактерном септическом шоке и ранней фазе ОРДС — по рекомендациям по неотложным состояниям в ОРИТ.

Антибактериальная терапия проводится при сопутствующей бактериальной инфекции, неэффективности противовирусной и симптоматической терапии, ОРДС и подозрении на вирусно-бактериальную пневмонию — по рекомендациям по внебольничной пневмонии и ОРДС.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Вакцинация проводится всем, не имеющим противопоказаний, в предэпидемический период и заканчивается **за 2–3 недели** до начала эпидемического сезона.

В первую очередь прививают

1. беременных;
2. взрослых **старше 60 лет**;
3. лиц с хроническими заболеваниями, в том числе лёгких и сердечно-сосудистыми, с ожирением;
4. работников медицинских и образовательных организаций.

Экстренную химиопрофилактику ингибиторами нейраминидазы проводят избирательно; если с первого контакта прошло **более 48 часов**, она не рекомендуется. Плановая профилактика осельтамивиром не рекомендуется из-за резистентности. Химиопрофилактика не заменяет вакцинацию.

1. #осельтамивир: по 75 мг 1 раз в сутки **не менее 10 дней** после контакта, начать **в первые 2 дня**;
2. занамивир: 2 ингаляции по 5 мг 1 раз в день, 10 дней;
3. балоксавир марбоксил: однократно **в течение 48 часов** после контакта, 40 мг при массе 40–80 кг, 80 мг при 80 кг и более;
4. умифеновир: по 200 мг в день 10–14 дней после контакта.

При больном в семье

1. изолировать больного в отдельном помещении или за ширмой на расстоянии более 1 м;
2. часто проветривать и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами;
3. кипятить посуду больного, мыть руки после каждого контакта;
4. носить маски со сменой каждые 2 часа.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. тяжёлое и среднетяжёлое течение гриппа;
2. проживание в общежитиях и в условиях неблагоприятных факторов жилой среды;
3. принадлежность к группе риска неблагоприятного течения болезни.

Признаки прогрессирования — схему ведения пересматривают срочно

1. одышка, затруднённое дыхание, синюшность, кровянистая мокрота, боль в груди, гипотония, гипоксия по пульсоксиметру;
2. изменение психического состояния, сонливость, судороги, спутанность сознания, сильная слабость или паралич;
3. устойчивая репликация вируса или вторичная бактериальная инфекция, в том числе высокая температура **более 3 дней**;
4. тяжёлое обезвоживание.

Показания к переводу в ОРИТ (достаточно одного)

1. быстро прогрессирующая острая дыхательная недостаточность, нарастающая одышка, цианоз;
2. ЧДД **более 30** в минуту, SpO_2 **менее 90%**, систолическое АД **менее 90 мм рт. ст.**;
3. шок, дисфункция ЦНС (менее 15 баллов по шкале комы Глазго);
4. острая почечная или печёночная дисфункция, коагулопатия.

Критерии выписки

1. нормализация температуры тела;
2. купирование респираторно-катарального синдрома;
3. нормальные показатели общего анализа крови.

Группы риска тяжёлого течения

1. беременные на любом сроке и в послеродовом периоде;
2. хронические заболевания лёгких, сердечно-сосудистой системы, почек, печени;
3. сахарный диабет, ожирение 2–3 степени;
4. неврологические состояния, гемоглобинопатии;
5. первичные и вторичные иммунодефициты, злокачественные новообразования;
6. возраст **65 лет и старше**.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Грипп у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 26.09.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	749_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского; Российское научное медицинское общество

	терапевтов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Раздел 3.1.1 рекомендует противовирусные препараты прямого действия «всем пациентам с симптомами гриппа», а комментарий к осельтамивиру и занамивиру указывает, что пациентам вне группы риска с неосложнённым гриппом ингибиторы нейраминидазы назначать не следует.
- Пороги дыхательной недостаточности различаются: для осмотра анестезиолога-реаниматолога (раздел 2.5) — ЧДД более 25 в минуту и SpO_2 менее 92%, для перевода в ОРИТ (приложение А3) — ЧДД более 30 и SpO_2 менее 90%.